

Definition Demenz

Nach dem internationalen System zur Klassifikation von Krankheiten gilt für die Demenz folgende Definition:

- Demenz (ICD-10-Code: F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen,
- einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache, Sprechen und Urteilsvermögen im Sinne der Fähigkeit zur Entscheidung
- Das Bewusstsein ist nicht getrübt
- Für die Diagnose einer Demenz müssen die Symptome nach ICD über mindestens 6 Monate bestanden haben

Präambel zum Expertenstandard:

- Die mit Demenz einhergehende Veränderung haben für Betroffene und ihre Angehörigen tiefgreifende und umfassende Folgen
- Diese zeigen sich, bedingt durch Veränderungen in der Interaktion und Kommunikation, insbesondere in der Beziehungsgestaltung
- Sie beeinträchtigen die Fähigkeiten von Menschen mit Demenz sich zu orientieren, etwas zu verstehen oder beurteilen zu können und wirken sich auf emotionales und soziales Verhalten aus
- So erschüttert die Erfahrung der Demenz Gefühle der Sicherheit und Geborgenheit, was u.a. zu Ängsten führen kann, die aufgrund von erlebter Unsicherheit, Bedrohung und Trennungssituation entstehen können
- Darauf kann seitens der Menschen mit Demenz u.a. mit Rückzug oder einem bindungssuchendem Verhalten z.B. Blickkontakt, wiederholtes Rufen etc. reagiert werden

Zielsetzung

Jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung, die das Gefühl gehört, verstanden und angenommen zu werden, sowie mit anderen Personen verbunden zu sein, erhalten oder fördern

Im Einzelnen bedeutet dies:

- Im Mittelpunkt steht die Beziehungsgestaltung und -förderung
- Umsetzung einer person-zentrierten Pflege
- Wahrnehmung der Einzigartigkeit des Menschen steht im Mittelpunkt nicht die Erkrankung Demenz
- Umsetzung eines individuellen Unterstützung- und Beziehungsbedarfes
- Menschen mit Demenz als gleichberechtigtes Gegenüber wahrnehmen und anerkennen
- Aufrechterhaltung der Personseins, Erhaltung und Förderung der Gefühle, verstanden und angenommen sein-, sowie das Gefühl mit anderen Personen verbunden zu sein

Zielgruppe

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	1	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Personen mit diagnostizierter Demenz, sowie bei Personen mit Beginn des pflegerischen Auftrages bzw. im Verlauf der Pflege sich Anzeichen einer Demenz zeigen (auch ohne Demenzdiagnose)
- Angehörige werden auf Wunsch und nach Möglichkeit einbezogen
- Abwehrendes und herausforderndes Verhalten, palliative Versorgung und spezielle Versorgung von Menschen mit frontotemporaler Demenz sind in diesem Expertenstand nicht ausdrücklich beschrieben

Anwender des Expertenstandards

- Pflegefachkräfte auch ohne spezielle Weiterbildung in gerontopsychiatrischen Bereich

...ohne Kompetenz geht es aber kaum....

- Entsprechende Kompetenzen erlangen Pflegefachkräfte beispielsweise in Fortbildungen, Weiterbildungen zur gerontopsychiatrischen Fachpflege oder durch ein pflegewissenschaftliches Studium, wenn dieses Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen einen solchen Schwerpunkt aufweisen
- Neben Pflegefachkräften werden auch Assistenzkräfte einbezogen (unter fachlicher Reflexion einer Pflegefachkraft)

Voraussetzungen für die Anwender des Expertenstandards

- Person-zentrierte Haltung und person-zentrierte Praktiken in der Pflege und Betreuung entfalten sich nur, wenn sie durch das gesellschaftliche Umfeld getragen werden
- In der professionellen Pflege geht es um die Wende von der funktionellen Ausrichtung der Pflege hin zu lebensweltorientierten und person-zentrierten Beziehungsgestaltung

Kurzbeschreibung der einzelnen Handlungsebenen

Ebenen des Standards	Kurzbeschreibung
1. Handlungsebene	Erfassungs- und Einschätzungsebene Unterstützungsbedarf in der Beziehungsgestaltung, deren Auswirkungen auf Lebens- und Alltagswelt sowie Vorlieben und Kompetenzen von Menschen mit Demenz
2. Handlungsebene	Planung von individuell angepassten beziehungsfördernden und gestaltenden Maßnahmen
3. Handlungsebene	Information, Anleitung und Beratung
4. Handlungsebene	Beziehungsfördernde und gestaltende Angebote der Einrichtung
5. Handlungsebene	Evaluation

Pflegeprozessschritt –Informationssammlung

1. Erste Handlungsebene des Expertenstandards

Bei Neuaufnahme erfolgt die pflegfachliche Einschätzung der Ist-Situation der pflegebedürftigen Person, an Hand der Themenfelder der Strukturierten Informationssammlung (SIS® ambulant/teilstationär/stationär/ Kurzzeitpflege)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	2	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Entlang der Themenfelder erfolgt dabei die Erfassung und Einschätzung des Unterstützungsbedarfs in der Beziehungsgestaltung, deren Auswirkungen auf Lebens- und Alltagswelt, sowie Vorlieben und Kompetenzen des Menschen mit Demenz
- Die Pflegedokumentation enthält, der Dauer und dem Anlass des pflegerischen Auftrags entsprechend, systematische und konkretisierende Hinweise auf mit der Demenz einhergehende Unterstützungsbedarfe in der Beziehungsgestaltung (Themenfeld 1-6 / Verständigungsprozess)
- Die vom Facharzt gestellte medizinische Demenzdiagnose wird in der Dokumentation im Bereich Ärztliche Diagnosen erfasst und in den entsprechenden Themenfeldern wird darauf Bezug genommen
- Werden Anzeichen einer Demenz identifiziert, werden diese ebenfalls in der Strukturierten Informationssammlung SIS® dokumentiert und an den Fach- und/oder Hausarzt nachvollziehbar weitergeleitet
- Für eine vertiefte Einschätzung kann der Mini-Mental-State-Examination (MMSE) © Folstein & McHugh eingesetzt werden
- Bei Planungen nach AEDL gilt das o. g. entsprechend

2. Handlungsebene des Expertenstandards

- Planung von individuell angepassten beziehungsfördernden und gestaltenden Maßnahmen
- Die pflegebedürftige Person und ihre Angehörige werden über demenzielle Erkrankung, ihre Ausprägung und mögliche *fluktuierende Zustände* durch die Pflegefachkraft informiert und erhalten eine fachliche Aufstellung von möglichen beziehungsfördernden Unterstützungsmaßnahmen
- Durch die Einbeziehung des Betroffenen und seiner Angehörigen wird auf Grundlage einer Verstehenshypothese eine individuell angepasste beziehungsfördernde und gestaltende Maßnahmenplanung erstellt und in den Tagesablauf integriert
- Bei den geplanten Maßnahmen wird dem **WIE** eine größere Bedeutung gegeben als dem **WAS**
- In erster Linie geht es nicht darum, möglichst viele beziehungsgestalterischer Angaben in der Maßnahmenplanung aufzunehmen, sondern vielmehr darum, sich damit zu befassen, wie diese Angebote gemeinsam mit dem Menschen mit Demenz realisiert werden können
- Der Schwerpunkt der Angebote liegt dabei auf Partizipationsverhalten in Einzel/Gruppenangeboten
- Wie Aufmerksamkeit für die anstehende Aktivität erreicht werden kann

Maßnahmen und Methoden zur Unterstützung der Beziehungsgestaltung

- Personenzentrierte Pflege nach Kitwood
- Validation/IVA
- Anpassung Milieutherapie
- Basale Stimulation
- Zehn-Minuten-Aktivierung
- Erlebensorientierte Pflege - mäeutischer Ansatz
- Erinnerungspflege
- Therapeutischer Tischbesuchsdienst (TTB)
- Tiere im Heim
- Snoezelen
- Aromapflege
- Musik in der Pflege

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	3	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Humor in der Pflege
- u. v. m.

Der dementiell Veränderte wird in den Alltag mit eingebunden Es wird nicht über ihn bestimmt, sondern er hat nach wie vor ein Selbstbestimmungsrecht

Voraussetzung:

- Empathie (Einführendes Verstehen)
- Akzeptanz (Wertschätzung)
- Kongruenz (Echtheit)

3. Handlungsebene des Expertenstandards

- Information, Anleitung und Beratung
- Für eine wirkungsvolle person-zentrierte Beziehungsgestaltung ist die Zusammenarbeit gemeinsam mit der pflegebedürftigen Person und allen an der Versorgung Beteiligten von entscheidender Bedeutung
- Durch gezielte Information und Beratung sorgt die Pflegefachkraft für ein Problemverständnis bei den Angehörigen der betroffenen Person
- Dies geschieht durch gezielte Informationsweitergabe, individuelle Beratung unter Einbezug aktueller Informations- und Beratungsmaterialien
- Ziel ist es, dass alle Beteiligten eine abgestimmte und individuelle person-zentrierte Beziehungsgestaltung unterstützen

Beratungsinhalte

- Vermittlung von allgemeinen Informationen zum Krankheitsbild (Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie)
- Vermittlung von Informationen zum Krankheitsverlauf und seinen Folgen auf die Verhaltensweisen des Betroffenen
- Information und Beratung über mögliche individuelle und über die Einrichtung möglichen Betreuungsangeboten (Gruppen- und Einzelangebote) und beziehungsfördernde Maßnahmen
- Befähigung der Bezugspersonen zu einer der Situation angepassten Umgang mit dem Betroffenen und positiven Beziehungsgestaltung
- Die Wirkung eines Krankenhausaufenthaltes, sowie die Konsequenzen dessen für die poststationäre Versorgungsgestaltung
- Alle edukativen Maßnahmen zielen sowohl auf Alltags- als auch auf Ausnahmesituationen
- Reizarmut
- Die Aufnahme in ein Krankenhaus, beinhaltet verunsichernde Umgebungswechsel, Kommunikationsabbrüche
- Gefährdungsrisiken
- Dem ist durch entsprechende Information, Anleitung und Beratung in Form möglichst kontinuierlicher Begleitung zu begegnen

Die Beratung und Reaktion auf die Angebote sind zu dokumentieren!

4. Handlungsebene des Expertenstandards

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	4	Verw./MA

Beziehungsfördernde und gestaltende Angebote der Einrichtung

- Alle Interaktionen finden in Ruhe und angemessener Langsamkeit statt
- Der Tagesablauf wird mit positiven Erlebnissen gestaltet und die Alltagsrituale werden individuell in die Tagestrukturplanung mit integriert
- Dabei wird darauf geachtet, dass es zu keinem ständigen Wechsel zwischen wechselnden und monotonen Abläufen kommt
- Das Wohnumfeld in der Einrichtung und im Zimmer der pflegebedürftigen Person, ist in wahrnehmungsfördernder Art und Weise gestaltet z.B. durch persönliche und vertraute Alltagsgegenstände oder auch Erinnerungen an die frühere Arbeitswelt

Dimensionen der angebotenen Maßnahmen

a. Lebensweltorientierung

- Biografie geleitete Gestaltung der Umgebung und des Alltags
- Kommunikation und Interaktion anzuregen
- Gespräche über vertraute Alltagshandlungen

b. Wahrnehmungsförderung

- Eigene Lautstärke
- Wortwahl
- Emotionale Tönung - damit eine Resonanz des gegenüber gelingt

c. Wertschätzung und Zuwendung

- Sicherstellung des notwendigen Präsenz und Nähe, um eine vertraute Bezugsperson zu werden.

d. Erwünschte Aktivitäten

- Einzel-/ Gruppenangebote in Alltagssituationen z.B. Singkreis beim Kaffee trinken
- Gartenarbeit, Kochen, Handwerkern, Singen, Malen, Musik (z.B. zum Einschlafen) und Tanz
- Bei plötzlichen Anzeichen von Unruhe -Handeln umstellen

Berichteblatt

- Abweichungen von den geplanten Betreuungsangeboten und beziehungsgestaltenden Maßnahmen, sowie Verhaltensänderungen werden im Berichteblatt erfasst
- Fallbesprechung/Fallgespräch werden bei Bedarf durchgeführt und im Berichteblatt dokumentiert und die erforderlichen Anpassungen in der Maßnahmenplanung vorgenommen und durchgeführt



5. Handlungsebene des Expertenstandards

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	5	Verw./MA

Evaluation

Ziel

- Betroffener fühlt sich gehört, verstanden, angenommen sowie mit anderen
- Personen verbunden
- Hier wird eine kriteriengeleitete Vorgehensweise empfohlen:
 - A. Stimmung und Affekt
 - B. Beziehung und Interaktion zu Mitmenschen
 - C. Betätigung und Eingebunden-Sein (Teilhabe)
 - D. Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit
- Die Einschätzung zu diesen Dimensionen und zum laufenden Beziehungsprozess erfolgt im Berichtsblatt und wird in Fallbesprechungen besprochen und ausgewertet

Kleiner Evaluationskreislauf

- Die Evaluation findet täglich im pflegerischen Alltag statt
- Bei jeder Pflege- und Betreuungshandlung wird automatisch durch den Mitarbeiter die Eignung der angewendeten Maßnahme überprüft
- Veränderungen und Abweichung werden im Berichtsblatt erfasst und z.B. im Rahmen der Schichtübergabe/einer Fallbesprechung besprochen und bei Bedarf werden Anpassung direkt in der Maßnahmenplanung vorgenommen

Großer Evaluationskreislauf

Eine neue vollständige Einschätzung der pflegerischen und betreuenden und pflegerischen Situation erfolgt über die Strukturierte Informationssammlung SIS® bei folgenden Ereignissen:

- Im Rahmen der Eingewöhnungsphase (6-8 Wochen nach Einzug)
- Bei gravierenden gesundheitlichen Veränderungen, z.B. Veränderung des Verhaltens der Kognition
- Nach Krankenhausaufenthalt
- Gilt für die Anamnese entsprechend

Person-Zentrierung

- Für Person-Zentrierung existiert KEINE einheitliche Definition
- Verschiedene Theorien und Modelle nähern sich einem Verständnis vom Umgang mit Menschen mit Demenz an
- Es geht dabei um die Anerkennung der Einzigartigkeit und der Individualität der Person, als wesentliche Voraussetzung für das Erleben von Wohlbefinden (Selbstbestimmung)

Personenzentriert arbeiten heisst nicht, eine Person losgelöst von ihrem Umfeld zu sehen, und vor allem nicht, die Person zum Problem zu machen.

Jede Problematik wird mitbestimmt durch soziale, institutionelle und zwischenmenschliche Aspekte, die mit einbezogen und hinterfragt werden müssen.

Der personenzentrierte Ansatz arbeitet nicht mit Deutungen und theoretischen Erklärungen, sondern mit dem Bestreben, sich in die Welt anderer Menschen einzufühlen und sie aus ihrer Sichtweise heraus zu begreifen. Es geht um Verstehen, nicht um Erklären, das ist ein wichtiger Unterschied. Verstehen heisst versuchen, die andere Person von innen heraus, in ihrer ganz

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	6	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

persönlichen Art des Erlebens, Denkens und Fühlens zu erfassen. Das ist die Grundlage der personenzentrierten Arbeitsweise. Personenzentriert arbeiten heisst mit den betroffenen Menschen, nicht für sie Lösungen suchen und Wege finden. Dabei muss man sich stets bewusst sein: Betreuung heisst nicht machen, sondern ermöglichen.

Personenzentriert arbeiten ist in erster Linie eine Haltung, nicht eine Methode, obschon es dafür durchaus methodische Richtlinien gibt. Denn eine Haltung darf nicht in schönen Worten steckenbleiben, sondern muss sich im täglichen Handeln verwirklichen.

Im Mittelpunkt der personenzentrierten Pflege nach Kitwood steht nicht die Person-mit-DEMENTZ, sondern die PERSON-mit-Demenz, das Subjekt selbst und nicht seine Krankheit. Wie Karin Welling schrieb, ist es nicht der Mensch mit Demenz und nicht der Demente, der Demenzkranke, nicht der Schreier und Frager, nicht der Wegläufer und Kotschmierer und auch nicht der Wanderer, der im Fokus steht. Nein, das ist der Mensch, die Person, die hinter der Diagnose Demenz steht.

Ziel der personenbezogenen Pflege besteht darin, dass das Personsein von Menschen mit Demenz erhalten bleibt und gefördert wird. Es ist sehr wichtig, der Person mit Demenz das Gefühl zu geben, etwas wert zu sein, etwas tun, etwas bewirken zu können, Kontakt zu anderen Menschen zu haben und dazu zu gehören, das Gefühl von Sicherheit, Urvertrauen und Hoffnung (Morton 2002, S. 152 und Müller-Hergl, 2000, S. 256).

Die Menschen mit Demenz befinden sich meist in einer verzweifelten Situation. Sie brauchen jemanden, der ihre Situation versteht und ihr Leiden anerkennt, ihm Stärke, Verlässlichkeit, Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Das kann durch Körpersprache und Körpersignale gelingen: ein verständnisvolles Nicken, Halten einer Hand, Abwischen von Tränen, Umarmen, Streicheln (Kitwood 2004, S. 123). Eine Person, die in kurzer Zeit mehrere Bindungen verloren hat, ist davon bedroht, sich selbst zu verlieren (Kitwood 2004, S. 123).

Solche Personen benehmen sich oft wie kleine Kinder: sie klammern an und laufen hinter einem her. Sie sind nicht in der Lage, von sich aus Beziehungen zu gestalten. Jeder Mensch braucht sozialen Kontakt, er wünscht sich, in die Gruppe einbezogen zu werden. Einbeziehung kann dadurch unterstützt werden, dass dem Menschen mit Demenz die Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten ermöglicht wird.

Beschäftigt zu sein bedeutet, keine Langeweile, Apathie und Bedeutungslosigkeit zu verspüren. Man kann sowohl allein als auch in einer Gruppe beschäftigt sein. Es ist sehr wichtig, eine richtige Art der Beschäftigung für den Menschen mit Demenz zu finden sowie den richtigen Grad der Unterstützung. So wird die Person nicht unter- und überfordert. Identität bedeutet, dass man in der Lage ist, über sich selbst eine Geschichte zu erzählen: Wo komme ich her? Wie heiße ich? Wo gehe ich hin?

Die Menschen mit Demenz brauchen die Unterstützung des sozialen Umfeldes. Durch identitätserhaltende Maßnahmen, wie Biographiearbeit und Erinnerungspflege, kann demenzkranken Menschen die Identität zu einem bestimmten Grad erhalten bleiben.

Die 12 personenzentrierte Ansätze nach Tom Kitwood

1. Erkennen und Anerkennen

Der Mensch mit Demenz wird als einzigartig anerkannt. Das gilt auch für seine Wahrnehmung und die für ihn gültige Realität. Wir hören der Person zu und sind dabei sowohl empathisch als

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	7	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

auch authentisch. Uns muss bewusst sein, dass unsere innere Haltung von einem Menschen mit Demenz wahrgenommen und gespürt wird.

2. Verhandeln und Aushandeln

So lange der Mensch mit Demenz seinen Willen ausdrücken kann, nehmen wir diesen an und respektieren ihn. Die Umsetzung des Willens wird mit dem Betroffenen ausgehandelt.

3. Zusammenarbeit

Wir arbeiten nicht „am“ Bewohner, sondern „mit“ dem Bewohner. Wir fördern seine Potenziale, geben Anleitung, wo nötig und zwingen ihn nicht in eine herbeigeführte Hilflosigkeit.

4. Zwecklosigkeit und Spiel

Wir Pflegekräfte wollen immer etwas von unseren Bewohnern. Waschen, Mahlzeiten anreichen, Toilettengänge durchführen etc. Dem Menschen mit Demenz tut es gut, wenn wir uns z.B. zu ihm setzen und einfach mal nichts wollen. Vielleicht reden wir, trinken gemeinsam etwas oder spielen. Auf diese Weise signalisieren wir ihm, dass wir gerne bei ihm sind. Wem tut das nicht gut?

5. Basale Stimulation/Timalation

Timalation, griechisch, bedeutet in etwa: „ich ehre dich.“ Es wird häufig da eingesetzt, wo verbale Kommunikation nicht möglich ist. Wir kommunizieren über sensorische Reize und bieten dem Erkrankten Wahrnehmungsreize. Doch auch Menschen im früheren Stadium der Demenz erfreuen sich an sensorischen Reizen. Enthalten Sie sie ihnen nicht vor.

6. Feste feiern

In einer gemütlichen Atmosphäre mit mehreren Menschen zusammen zu sein baut häufig Spannungen ab.

7. Entspannen

Der Mensch mit Demenz benötigt genauso selbstverständlich Zeit für sich selbst, wie jeder gesunde Mensch auch. Geben wir ihm diese Möglichkeit und sind nicht überängstlich, wenn sich jemand auf sein Zimmer zurückzieht. Zum Glück arbeiten so viele Betreuungskräfte wie nie zu vor in der Pflege. Bedenken wir jedoch auch, dass unsere vielen Angebote die Menschen überfordern können.

8. Validation

Wir versetzen uns in den Menschen hinein, akzeptieren seine Wirklichkeit und damit ihn selbst als Person. Wir erkennen seine Emotionen an und bieten ihnen Raum.

9. Halten

Gerade im Pflegebereich wird viel über die Fähigkeit, Nähe und Distanz halten zu können, gesprochen. Entschuldigung; Wenn ein Mensch gedrückt und gehalten werden muss, bzw. das Bedürfnis danach hat, dann drücken und halten wir ihn. Wir sind empathisch und können uns vorstellen, wie schwierig es ist, mit Menschen zusammen zu sein, die eine andere Wirklichkeit erleben, als wir.

10. Erleichtern

Etwas nicht mehr tun zu können, was einem wichtig ist, bedeutet einen gewaltigen Verlust an Lebensqualität. Wir unterstützen den Betroffenen dabei, seine Handlungen durchzuführen und vermitteln ihm, dass er selbst an Ziel gekommen ist.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	8	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

11. Interaktion durch Symbole

Es ist bekannt, dass Menschen mit schwerer Demenz positiv auf immer gleich ablaufende Rituale reagieren. Ein stets wiederkehrender Tagesablauf bietet viel Sicherheit. Hier sind wir darauf angewiesen, dass alle Kollegen an einem Strang ziehen. Das setzt eine sehr gute Kommunikation im Team voraus.

12. Geben

Wir Menschen definieren uns über viele Dinge. Eines davon ist, dass ich für etwas, dass ich in Anspruch nehme, bezahle, oder mich revanchiere. Bei Menschen mit Demenz hört das nicht auf. Häufig möchten Sie uns für unsere Arbeit etwas geben und genauso häufig blicken wir in enttäuschte Augen, wenn wir ablehnen, sei es nun Geld, Schokolade oder Bonbons. Geben zu können, in diesem Fall sogar, zu dürfen, ist ein Zeichen von Dank, Anerkennung und Zuneigung. Darüber sollten wir uns freuen und es dem Betroffenen nicht verweigern.

Sie werden nicht von heute auf morgen ihre Arbeit und Ihren Wohnbereich revolutionieren. Doch sicher können Sie **Ihre Dienste angenehmer gestalten**, wenn Sie diese Interaktionen im Hinterkopf haben. Vielleicht, und das könnte ein Grund sein, weshalb es in Ihrer Schicht gut läuft, setzen Sie ganz intuitiv viele Aspekte bereits um. Schließlich handelt es sich bei den Interaktionen um ganz normales menschliches Verhalten, verpackt in ein Pflegemodell.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	29.03.2023		2	9	Verw./MA